

· 综述 · 论坛 ·

药品不良反应病例报道不可忽略药物相互作用

于星^① 张惠霞^②

关键词 联合用药;药物相互作用;药物不良反应/事件

中图分类号:R969.2 文献标识码:A 文章编号:1006-0698(2012)06-0298-03

在众多药品不良反应病例报道中,有同一疾病的联合用药,也有不同疾病的合并用药(以下将联合用药与合并用药统称联合用药),少则二三种,多则十几种。令人遗憾的是,多数作者在分析药物时未能充分考虑联合用药背景,在列举用药信息时没有公平采信所有的药物信息,也未将患者同一时间或间隔一段时间所用药物的全部信息一一列出,导致其他药物的信息缺失。在进行关联性分析时,或以时间的紧密程度推论药品与不良反应的“因果关系”;或以说明书已列入相同不良反应为由将药品对号入座。全文只将“怀疑”药品的信息作为重点介绍,并藉此认定不良反应由该可疑药引起。作者或无意或有意回避联合用药的信息,先入为主地认定不良反应由某药引起,忽略药物的相互作用,否认药物相互作用导致不良反应存在的可能性,引用证据缺乏说服力,以偏概全。这种现象较为普遍。

1 药物相互作用始于联合用药

药物相互作用是指联合用药时所发生的疗效改变^[1]。众所周知药物的相互作用会产生多种效应,并由此带来多种结果:或增强疗效、降低不良反应;或疗效减低、毒性增强,增加不良反应。药物的体内过程是药物与机体的互动过程,有机体对药物的处置——药物代谢动力学,也有药物对机体的作用——药物效应动力学。药物的相互作用始于联合用药,继因联合用药使得这一过程变得更加复杂。药动学层面的相互作用体现在吸收、分布、代谢、排泄的各个环节中,既有相互诱导,也有相互抑制;既有竞争拮抗,也有相安无事;药效学层面的相互作用体现在效应器官和作用部位,有相加和相乘作用,也有协同和拮抗作用。它们或相对独立,或相互穿插。由于药物在体内相互作用的过程被一道天然屏障所

遮蔽,这给不良反应的关联性分析增加了难度。

2 联合用药易致不良反应

联合用药是临床上常见的给药方法,极为普遍。联合用药为药物相互作用奠定了物质基础,同时也决定了药物的临床疗效。药物相互作用的最终结果是将单一药物的疗效变成了多个药物的综合疗效,而不良反应的出现则是药物相互作用不良效应的具体体现。联合用药的初衷显然是为了取长补短,但是,由于各种原因使得许多联合用药不尽合理,导致结果适得其反。究其原因是药物相互作用产生的不良反应所致。有资料显示,药物相互作用所致不良反应的发生率与合并用药数量成正比。除了药物自身潜在的不良反应之外,联合用药使得不良反应的发生率大比例增加。国外资料显示^[2]:2~5种药物联用,不良反应发生率为4%;6~10种药物联用,不良反应发生率为10%;11~15种药物联用,不良反应发生率为28%;16~20种药物联用,不良反应发生率为54%。总之,联合用药的品种越多,药物相互作用的机会就会增多,发生不良反应的概率就会增大。

3 联合用药是一个整体

机体、疾病、药物、给药方法是构成不良反应/事件的四大要件^[3],其中机体、疾病是事件的背景资料,药物、给药方法是事件的导火索和焦点。在不良事件的分析中,药物信息的完整性至关重要。为了得出客观公正的结论,应将联合用药看作一个整体,在排除了药物以外的因素之后,应将所用药物无一例外地列为怀疑对象,对联合用药进行一一梳理。在整理药物信息的过程中,均等对待每一个药物,完善每一个药物的信息同等重要。在病例报道中应客观展示每一个药物的信息,不可偏废,不可“厚此薄彼”。完整的药物信息点应包括:①药品名称;②药物过敏史(包括家族的和个人的);③适应证;④禁

①武汉大学人民医院(武汉 430060);②河南省食品药品评价中心。

忌证;⑤用法用量;⑥配伍浓度;⑦给药速度;⑧给药频度;⑨用药起止时间,其中包括调整剂量后的用法用量和起止时间。

4 药物相互作用是不良反应研究领域的“高地”

药物相互作用致不良反应一直是不良反应研究领域里的“高海拔区”。受客观条件所限,研究和评价联合用药出现的不良反应也一直是世界性难题,目前暂无标准可言。药物相互作用致不良反应在临床上虽屡见不鲜,但见诸报道者却凤毛麟角。原因之一是个案病例属于微观层面,具有很强的特殊性,个体差异很大,病例不仅难以复制,也难以获得足够的临床验证资料和实验数据。原因之二是人们对体内药物相互作用始终缺乏有效的观察技术和监测方法。客观地说,目前尚无法获得直视或模拟药物在体内的药动学、药效学过程的方法。透过药物产生的种种效应,我们所能观察到的是一个或好或不好的治疗结果,但我们却看不到产生这些结果的脉络,也不可能循着这些结果去获得一个明晰的体内药物相互作用的3D视图。苦于观测技术长期落后于人们的意识形态,客观上造成了人们对药物相互作用终点和结果的“盲视”(视而不见)和“短视”(以为这是个无关紧要的问题)。因此,人们在对不良反应病例报告进行分析时,不再关注药物相互作用这类问题。

5 如何运用“第五原则”

目前,关于联合用药致不良反应的唯一文字依据是国家不良反应监测中心关于不良反应因果关系判定原则中的第五条(简称第五原则),即“是否可用并用药的作用、……的影响来解释”^[4]。该原则提示联合用药有致不良反应的可能性,同时也为研究药物相互作用致不良反应预留了空间(本处仅围绕药物因素展开)。在联合用药致不良事件中,第五原则成为不良反应分析中绕不开的“槛”。这个“槛”设的好!假如要在一堆联合用药中“指证”某药物为独立“元凶”的话(针对忽略药物相互作用),也就等于同时否定了其他药物和联合用药致不良反应的可能性。此时,必须多方位提供元凶“肇事”的证据,除此之外,还应提供其他药物无“协同”可能性的证据以及药物相互作用无此可能性的证据。实践中论证的方法有多种,此处推荐“排除法”作为分析思路,举例一二,且作抛砖引玉。

例1:假如有四组输液,分别编号a、b、c、d。当d组输液中或输液结束后出现了不良反应,并且连

续有两次(此条件必须满足)或二次以上的经历。有可能会首先怀疑d药,如何判断d药物是不是引起不良反应的“元凶”呢?如何排除a、b、c药物的“嫌疑”呢?(假定前提:已确认不良反应由药物所致,如何在联合用药中找出“元凶”。)

可用一个小试验来检验:把d组输液与a组顺序对调,将d组放到第一时间输液。如果d药在输液过程中或输液结束后(第二组输液之前)出现了与前述相同的不良反应(此条件必须满足),则推定d药可能是“元凶”;如果调换后没有出现前述不良反应,说明“元凶”另有其“药”;如果四组药物都输液完毕后出现了前述不良反应,说明a、b、c、d四药均有嫌疑。可以重复使用上述方法,一一排除,直至找出“元凶”。

例2:(针对根据已知某药有此类不良反应推定因果关系)同样是a、b、c、d四组输液,当d组输液结束后,患者出现了“头痛”、“视力模糊”。已知d药有此类不良反应。能不能仅凭此将d药定为“元凶”呢?能不能以此判定其他药物毫无干系呢?

可做以下两项调查:首先查看a、b、c药物说明书是否列有此类不良反应;其次了解原患疾病或并发症是否会导致此类症状和体征。如果a、b两药说明书也列有此类不良反应,而原患疾病等没有此类表现,说明d药不是唯一的“元凶”,同时说明a、b药均为“元凶”;如果原患疾病等也有此类表现,说明认为d药是“元凶”的推断是不成立的。

例3:(针对忽略药物相互作用,仅凭时间紧密程度推定因果关系)同样是a、b、c、d四组输液,当d组输液结束后,患者出现了“心动过速”、“胸闷”,原因不明。d药是“元凶”吗?如何判断?

应首先了解原患疾病和并发症是否会引起这些症状体征。在排除原患疾病与并发症因素之后,分别查阅a、b、c、d四药的说明书或文献(a、b、c、d单药应用产生ADR),如果说明书、文献均无此类不良反应,则可判定“心动过速、胸闷”为药物相互作用所致。

对于联合用药出现的不良反应,由于受客观条件制约,很多时候难以做出判断。出现这种情况,观察人不必急于做结论,也不必急于述诸成文。可通过排除法进行反复观察,也可采用“疑罪从无”的原则。尽量做到用证据说话,尽量做到以理服人,让作者阐述的论点更加合理,更加令人信服。

6 结语

联合用药是客观存在的,药物有相互作用也是

国外关于哺乳期使用口服抗糖尿病药的新观点

张峻^① 黄桦^① 柳汝明^① 姚勤^①

关键词 抗糖尿病药;磺脲类;二甲双胍;哺乳期

中图分类号:R977.1*5 文献标识码:A 文章编号:1006-0698(2012)05-0300-03

随着2型糖尿病在年轻人中的发病率越来越高,妊娠合并2型糖尿病的妇女也越来越多^[1,2],这些孕妇很多在怀孕前使用口服抗糖尿病药,尽管在孕期她们调整为使用胰岛素,但由于注射疼痛、使用不方便、价格较高等原因,当她们分娩后就想尽快恢复使用口服抗糖尿病药^[3]。一直以来,人们通过动物试验了解到第一代磺脲类抗糖尿病药可以通过乳汁分泌(尽管很少)^[4,5],为了避免新生儿低血糖的发生,口服抗糖尿病药是不推荐给哺乳期妇女使用的。自2000年美国学者将格列本脲用于妊娠中、晚期,由于该药胎盘透过率极低,治疗剂量时,胎儿脐血中检测不出该药,目前在许多国家已将该药用于妊娠期糖尿病治疗中^[6],因此有人开始关注哺乳期使用口服抗糖尿病药是否可行的问题,下面就国内

外哺乳期使用口服抗糖尿病药的一些临床研究做一简介。

1 磺脲类药物

磺脲类抗糖尿病药是治疗2型糖尿病的常用药物,其中第一代磺脲类药物(如:氯磺丙脲、甲苯磺丁脲)由于具有较高的不良反应发生率,所以现在已很少使用,相比较而言,第二代磺脲类药物(如:格列本脲、格列吡嗪、格列美脲、格列齐特)则疗效更好、不良反应更少。2000年Ito^[7]采用非随机对照法研究了格列本脲和格列吡嗪在乳汁中的分泌情况,结果在乳汁样本中均未检测到格列本脲和格列吡嗪。在最近的一篇报道中^[8],加拿大研究人员给予刚分娩的产妇第二代磺脲类药物治疗,并分为单

①昆明医学院第一附属医院临床药学中心(昆明 650032)。

客观存在的。忽略联合用药、忽略药物相互作用致不良反应,势必造成药物信息的失真。其后果也许暂时无法估量,但文章一旦发表这些病例报道自然形成为文献,其影响也是无法估量的。或许会被用来佐证某药物的安全性,或许会被选入文献综述,或许会被反复引用。不难想象,这些文章起了什么作用?以“讹”传“讹”!联合用药致不良反应的背景被当作单一用药,事实真相被掩盖,弊端即由此产生。

对不良反应的相关性进行分析,是药物警戒学学术探讨的需要。分析方法可以见仁见智,但不可违背客观事实。无论是临床观察还是学术文章不仅需要客观、实事求是,而且需要严谨。否则探讨就失去了意义。值得一提的是,现阶段虽然无法获得药物相互作用致不良反应的直观证据,也不能对联合用药产生的相互作用做出明晰的阐述,但不能否认和无视联合用药的存在,也不能基于某一“视角”否

定其他药物和药物相互作用的存在。作为学术文章,在未还原事物的本来面貌的情况下,有违客观、公正、事实求实的精神,所得结论必然是不科学的,也有误导读者之嫌。这不是科技工作者应有的态度,也是应尽力避免的错误。

参 考 文 献

- 1 徐淑云. 临床药理学[M]. 北京:人民卫生出版社,1999. 161
- 2 王士凡,孙定人,王立功,等. 药物不良反应[M]. 北京:人民卫生出版社,1996. 22
- 3 于星,唐荣福,王卫星,等. 药品不良反应防护[M]. 武汉:湖北科技出版社,2000. 100-109
- 4 吴笑春. 药源性疾病诊治手册[M]. 北京:人民军医出版社,2005. 31

(2012-03-12 收稿 2012-04-13 修回)

[通讯作者]于星, Tel:13554536390, E-mail:da_youxiang@163.com